

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22231024644

ANDRE RAIF AMMOURI

IDADE: 61	PESO: 150	ALTURA: 189	PROFISSÃO: Corretor imóveis
SINTOMAS: nega sintomas - nega refluxo gastr.			
QUEIXAS:			
MEDICAMENTOS: Hara-2 / Sintroid 100			
HAS			
MÉDICO: Drª Carolina			
MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N			
EXERCÍCIO FÍSICO: 2x semana personal (NOV 2023) (1x sem. drenagem)			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: N LANCHE: N JANTAR: S			
HORA QUE DORME: 2 hr		HORA QUE ACORDA: 9 - 10	
COCHILHO (X) SIM () NÃO 18-19		DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO: 0x - (2x) à noite	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: global +		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI: IV	IAH: 113; 7 e/ SPO2: 69%	
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: (N) NASAL (X) AMIGDALECTOMIA (retirou)			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA			
(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS			
17/05 em 2019 - teve probl. tireoide e ↑ de peso.			
24			
24/05	P = 11.2 cmH ₂ O	Relata melhora do	
24	IAH = 3.6 e/év	cansado.	
	m. de uso = 6h33'		
	Fuga = 8.0 lpm.	fua	
06/06	P = 10.9 cmH ₂ O	- não levanta mais p/ ir ao	
24	IAH = 1.7 e/év	banheiro.	
	m. de uso: 8hr.	- Oriento ir dormir + aplo.	
	Fuga = 6.7 lpm.	fua.	
	Comprou CPAP automático.		
10/07	P = 10.6 cmH ₂ O	faz drenagem luf.	
24	IAH = 1.4 e/év	fua	
	m. de uso: 11.4 lpm.		
12/08	P = 10.6 cmH ₂ O	relata estar q obstrução	
24	IAH = 1.1 e/év	nasal. (1x ao banheiro)	
	m. de uso: 6h11'	fua	
14/10	P = 10.2 cmH ₂ O		
24	IAH = 1.7 e/év		
	m. de uso: 6h10'		
	fuga = 5.4 lpm.	fua	

06/12/24 $P = 9,9 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,6 \text{ e/h}$
m de uso: 6h11'
fuga: 7,9 l/m

Natacha

11/03/24 $P = 10,3 \text{ cmH}_2\text{O (med)}$
 $IAH = 1,2 \text{ e/h}$
m de uso: 6h24'
fuga: 23,5 l/m

Natacha

12/05
25 $P = 9,5 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,7 \text{ e/h}$
m. de uso: 6h40'
fuga: 17,7 l/m.

Ana Cláudio

07/07
25 $P = 9,5 \text{ cmH}_2\text{O}$
Fuga: 24
 $IAH = 1,6$
m. de uso: 7h24'

Ana Cláudio



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: André Raif Ammouri

EXAME nº: 5581

SOLICITADO POR: Dra. Carolina Ruston Daher

DATA: 18/03/2024

IDADE: 61 anos

RESMED₁₀ AUTOMÁTICO

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

Comentários:

Exame iniciado às 23h37min e concluído às 06h11min. A latência para o sono foi de 6 minutos e a latência para o estágio REM, de 246 minutos. O tempo total de sono foi de 295,5 minutos (04h55min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 75%. A distribuição do sono mostrou 37,2% de estágio 1, 50,6% de estágio 2, 10% de estágio 3 e 2,2% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 92 minutos em vigília, ocorreram 188 microdespertares (índice: 38,2/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 113,7/hora, sendo 30,5 apneia/hora e 83,3 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 113,7/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, sendo a saturação média de 91% e a mínima de 69%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (113,7/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (113,7/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 75; máxima: 95 bpm.

O ronco foi contínuo e médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 6 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava alongada (246 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 75%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 38,2/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (37,2%; normal: 8-10%) e a redução do estágio REM (2,2%; normal: 20%). As porcentagens dos estágios 2 (50,6%; normal: 45-55%) e 3 (10%; normal: 10-12%) permaneceram nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Sem contrações masseterinas (usou a placa miorelaxante).

Escala de Sonolência de Epworth: 11 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, sl 51 e 52

Ed. Office Tower

Alberto Jorge Remesar Lopez